内科含诊断 糖尿病 ★★★（0~4 题）

治疗

控制目标

- HbA1c ＜ 7%、BP ＜ 130/80、BMI ＜ 24
- LDL-C：未合并 ASCVD ＜ 2.6、合并 ASCVD ＜ 1.8“爱点肉、一点吧”
  首选他汀类（但 TG ＞ 5.6 先用贝特类以防急性胰腺炎“我妻贝特”）

胰岛素

- 适应症（2014、2023）—— T1DM、T2DM 多种方式治疗后 HbA1c ≥ 7%、严重糖尿病并发症、手术、妊娠、分娩
- “3 短 1 长”（2009、2023）—— 三餐饭前给短效胰岛素或速效胰岛素类似物、睡前给长效胰岛素
- 早晨空腹血糖仍高（2009、2020）——
  ①整个夜间高血糖→夜间胰岛素应用不足→增加夜间胰岛素
  ②夜间血糖 3.9~6 →黎明现象→约 4~8 点给胰岛素
  ③夜间血糖＜ 3.9 → Somogyi 效应→减少夜间胰岛素

T2DM 胖胖（BMI ≥ 25）症状不重首选饮食运动疗法、否则首选双胍类

	药物	机制	备注
双胍类	二甲双胍	AMPK （GLP-1 ↑、肝糖原分解↓、肠摄取糖↓等）	T2DM 一线和基础药，很适合胖胖、胰岛素抵抗明显者 禁用：GFR ＜ 30（可致乳酸酸中毒，2010、2017）
GLP-1 受体激动剂	艾塞那肽	GLP-1：促胰岛素分泌（2025）	很适合 T2DM 胖胖、胰岛素抵抗明显者
DPP-4 抑制剂	格列汀	GLP-1：促胰岛素分泌	T2DM“打屁屁就听话”
SGLT-2 抑制剂	格列净	抑制糖在近端小管吸收“受够了糖清干净”	T2DM“降糖降压降脂等、护肾护心”
α- 糖苷酶抑制剂	阿卡波糖	延缓糖在小肠吸收（与食物同服“阿卡波糖拌饭”）	很适合 T2DM 胖胖降餐后高血糖“糖 - 固体”（2009）
格列奈类	格列奈	促胰岛素分泌	很适合 T2DM 瘦瘦降餐后高血糖“奶 - 液体”（2013）
磺酰脲类	格列 XX	促胰岛素分泌	只能用于 T2DM 瘦瘦 格列喹酮在中度肾功能不全也能用（2015）
噻唑烷二酮类	格列酮	PPAR	很适合 T2DM 胖胖、胰岛素抵抗明显者 禁用：心衰“心塞”

不良反应

最易发生低血糖：胰岛素＞磺酰脲类＞格列奈类（2007）
易发生胃肠道反应：α- 糖苷酶抑制剂、双胍类等（2007）
可致体重增加：胰岛素、磺酰脲类、格列奈类、噻唑烷二酮类、西格列他钠（2026）

伴随疾病

- T2DM 伴 ASCVD —— 双胍类、SGLT-2i（体重↓）、GLP-1RA 司美格鲁肽 / 替尔泊肽（体重↓）“3 个 G”
- 伴心衰、高血压（很高危）、肾病等（2023）—— ACEI/ARB
- 伴房颤 ——
  有瓣膜病→华法林长期抗凝
  无瓣膜病→ CHA2DS2-VASc 评分
- 伴急性膀胱炎 —— 7 日疗程

昏迷鉴别：HHS、DKA、脑水肿、乳酸酸中毒、低血糖（皮肤湿润）